

NOTULEN

HARI / TANGGAL : SABTU / 02 DESEMBER 2023
 PUKUL : 13:00 – SELESAI
 JENIS MEETING : KEBIJAKAN PERHITUNGAN HR DOKTER UROLOGI
 TEMPAT : ZOOM MEETING

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	dr. Pradana Nurhadi, Sp.U & dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	1. Penjelasan terkait tarif proporsi INAcbs	Jika tarif RS lebih kecil dari INAcbs maka akan mendapatkan jasa sesuai ketentuan yang tertuang pada SK	Manajemen
2.	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	Proporsi negative dan positive dijelaskan lebih lanjut kepada DPJP terkait tarif setiap Tindakan. Dijabarkan mulai dari Poli – Rawat Inap baik pasien operasi maupun non operasi	Apabila tarif proporsi positive maka dokter akan mendapatkan jasa 60.000 sedangkan apabila tarif proporsi negative maka akan mendapatkan jasa sesuai dengan proporsi. Selisih Lebih pada INACBGS bisa diberikan pada pasien dengan kebutuhan perawatan lainnya sesuai episode perawatan	Manajemen
3.	dr. Pradana Nurhadi, Sp.U	Bagaimana apabila proporsi negative meskipun tidak ada pemberian obat tetapi dikarenakan ada penggunaan pemeriksaan penunjang dan hasilnya (-) ? .	Pemeriksaan penunjang bisa diberikan pada hari dan kunjungan yang berbeda (Tidak harus dalam jangka waktu 7 hari) untuk mengontrol proporsi INAcbs. Manajemen RS wajib bekerjasama dengan DPJP untuk melakukan control biaya, dan TL ke programmer untu membuat system control biaya yang dapat dijadikan instrumen pengendalian di unit Layanan	Manajemen
4.	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	Tarif RS bisa di perbaiki disesuaikan juga agar bisa menyesuaikan INAcbs sehingga proporsi tidak memberatkan salah satu pihak	1. Harga obat sudah disesuaikan dengan proporsi dan diperbaiki sesuai jaminan (BPJS dan non BPJS) 2. Penentuan harga tarif juga telah dilakukan perbaikan sesuai dengan pelayanan	Manajemen



			Contoh tarif Rawat luka → sudah diperbaiki tarifnya. 3. Berbagai Upaya sudah dilakukan oleh Rumah Sakit dalam memperbaiki tarif termasuk dari masukan-masukan yang telah diberikan oleh stakeholder internal (DPJP) 4. RS membuka kebebasan berpendapat mengenai tarif yang mungkin masih mahal di RS sehingga bisa di diskusikan terkait penyesuaian harga. 5. Manajemen RS dan DPJP melakukan evaluasi Bersama mana tarif tindakan yang masih tinggi, dan mengajukan kepada PT dengan format dan prosedur yang telah disediakan	
6.	dr. Pradana Nurhadi, Sp.U & dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	1. Perbaikan system terkait harga muncul saat input sehingga ada note apabila terdapat proporsi negative 2. Perlu di tambahkan warning limitasi	Sudah di TL di SIMRS sudah ada harga dan biaya obat tetapi memang masih belum terkait warning limitasi plafon penggunaan. TL lebih lanjut ke manajemen RS dan programmer	Manajemen dan Programmer
7.	dr. Pradana Nurhadi, Sp.U	Simulasi terkait kunjungan kedua	1. Apabila pada kunjungan pertama melebihi INAcbs maka jasa dokter akan terpotong proporsi tetapi untuk kunjungan kedua dokter bisa memberikan obat dan tidak terpotong proporsi negative 2. Pada rawat jalan ada proporsi negative – standar – proporsi positive Proporsi positive akan diberikan pada akhir bulan dan terhitung saat penggajian	Manajemen
8.	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	Tindakan pasang kateter dan lepas kateter	INAcbs = 382.000 Pasang kateter= 120.000 Apabila tarif rs lebih dari 382.000 maka standar jasa	Manajemen

			dokter yang diterima tidak lagi 60.000 tetapi disesuaikan dengan perhitungan proporsi Jika DPJP dapat melakukan pengendalian biaya dengan memanfaatkan INACBG's 382.000 maka Tarif proporsi positive akan diberikan pada jasa remunisasi di akhir	
9.	dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	Rawat luka	Saran untuk rawat luka mungkin bisa di minimalisir pada penggunaan obat pulang yang diberikan kepada pasien, DPJP akan mencoba menerapkan dalam pelayanan	Manajemen
10.	dr. Pradana Nurhadi, Sp.U & dr. Ferdyan Rachmat Efendi, Sp.U	Rawat Inap 1. Apakah tarif Rumah Sakit sudah sebanding dengan tarif INAcbsg? 2. Bagaimana cara mengetahui jumlah perawatan dan tindakan kepada pasien RI yang sudah mendekati plafon? Selama ini DPJP tidak mengetahui hal itu. 3. Potongan 10% untuk jasa dokter saat Tindakan operasi. Komponen apa saja yang di potongkan RS 4. Di floorkan lebih lanjut terkait pemotongan 10% berdasarkan apa dan digunakan untuk apa karena setiap pelayanan dari dokter sudah dilakukan pemotongan.	1. Untuk menyesuaikan dengan INACBG's dilakukan evaluasi yang dilakukan RS, Baik tarif rawat inap maupun rawat jalan tetap dilakukan evaluasi. 2. Manajemen RS wajib menjalankan kendali biaya dan bekerjasama , komunikatif dengan DPJP yang sudah dijalankan RS asuransi center dan temen-temen rawat inap menginfokan kepada DPJP, Evaluasi kenapa DPJP URO belum memahami ini. 3. Akan dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait jumlah presentase nya. Untuk potongan 10% sudah ada di Hospital By Law, tidak hanya DPJP tetapi juga direksi. Diskusi lebih terbuka terkait beberapa masukkan dari DPJP 4. Potongan merupakan kebijakan dari internal RS terkait usulan dari DPJP juga akan dipertimbangkan dan akan menjadi masukkan untuk PT. Disa Prima Medika.	Manajemen



		5. Sebelum ada sistem proporsi sehingga tarif minimal masih layak untuk diterima dokter sehingga tidak bermasalah dengan potongan 10%, tetapi ketika ada penyesuaian tarif proporsi ini memberatkan DPJP → Saran dari DPJP dihapuskan saja terkait pemotongan 10% 6. Kebijakan baru apakah akan dilaksanakan atret?	5. Akan dilakukan diskusi lebih lanjut dengan manajemen terkait pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan oleh DPJP 6. Akan di diskusikan lebih lanjut dengan Pimpinan terkait kebijakan baru akan diberlakukan mulai kapan 7. Penggunaan ini dilakukan untuk pelayanan yang belum terbayarkan (Koordinasikan dengan pimpinan)	
11.	Jasa dokter	1. Jasa Rawat Jalan 2. Jasa Dokter dengan kasus bedah 3. Jasa Dokter Rawat Inap tanpa bedah	1. Jasa rawat jalan menggunakan proporsi jika tarif Rumah Sakit melebihi tarif INAcbs 2. Jasa dokter dengan kasus bedah menggunakan 20% dari INAcbs 3. Jasa dokter rawat inap tanpa bedah menggunakan tarif standar. Apabila tarif INAcbs lebih kecil dari tarif Rumah Sakit maka menggunakan proporsi Sudah acc dengan model tersebut	Manajemen

Pemimpin Rapat
Konsultan PT. Disa Prima Medika

Puguh Priyo.W., Amd. RMIK, S.Si, SKM,
MMRS, AAK, M. AK, CHIA

Malang, 02 Desember 2023
Notulis

Adinda Lestari Putri, S.KM

Mengetahui,
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Endang Susilowati

[illegible]

The screenshot shows a Zoom meeting with a presentation titled 'Struktur Biaya - edit log'. The presentation is a spreadsheet with the following data:

No	Batu ureter	Dokter	RS					
1	Jasa pemeriksaan dokter	300000	60000	40000	60000			
2	Obat	80000	0,3333333		65366,6667	100	800000	
3	Tarif RS	180000						
4	Tarif dan CBGs	396100						
5	Setelah	16100						

NOTULEN

Yang dilaksanakan pada : JUMAT / 01 DESEMBER 2023
Pukul : 15:30 WIB – SELESAI
Materi : KIE JASA PELAYANAN FISIOTERAPI
Tempat : LOKASI DINAS MASING – MASING (*Zoom Meeting*)

Berikut hasil notulen :

NO.	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Jasa Pelayanan	Kebijakan dari PT terkait jasa pelayanan siapapun yang melakukan input adalah yang mendapatkan jaspel.	Karena tindakan kepada pasien ditangani oleh 2/3 perawat maka kepala ruang fisioterapi membagi rata jasa pelayanan. Total jasa pelayanan di bagi rata kepada perawat unit fisioterapi	PHS
2.	Pasien umum	Input sistem untuk pasien umum	1. Disesuaikan dengan advice DPJP 2. Untuk tarif terlalu mahal bisa dibandingkan dengan sebelumnya 3. Tarif tetap di input satu persatu disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan mengacu kondisi demografi Rumah Sakit 4. Terkait pembuatan paket disesuaikan dengan diagnosa terapi terbanyak dan terapi rangkaian untuk pasien umum, sehingga sasaran pembuatan paketnya sesuai dengan kebutuhan pasien 5. Tarif juga disesuaikan dengan kehadiran dokter (harga bertemu dokter dan harga tidak bertemu dokter) → follow up lebih lanjut dengan programmer terkait pembuatan sistem	PHS dan Programmer
3.	Jasa Pelayanan pasien BPJS	Penyesuaian jasa pelayanan pasien BPJS	Pasien BPJS belum bisa dinaikkan dikarenakan disesuaikan dengan proporsi	PHS

Pemimpin Rapat


Sindy Novenia, S.Pd

Malang, 01 Desember 2023
Notulis


Adinda Lestari Putri, S.KM

Mengetahui,
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika


PT. DISA PRIMA MEDIKA

Endang Susilowati

DOKUMENTASI

